

جوستاف روسي انترناسيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هويدا فرحان محمود حسن
المحافظة : القاهرة
رقم البطاقة : 27710280103003 رقم التليفون : 01143409404
العمر(تاريخ الميلاد) : 28-10-1977 المهنة : ربه منزل
العنوان : ~~~~
تاريخ تسجيل الإستمارة : 21-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة:

الوظيفة:

الوظيفة:

التوقع:

التوقيع:

التوقيع:

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس

وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- /د ----- /د ----- /د. | ----- /د. |

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

رئيس

المجلس الطبي المتخصص

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

ختم

شعار الجمهورية

--

Name: هويدا فرحان محمود حسن National ID: 27710280103003	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



هويدا

فرحان محمود حسن

اش. عبد الرحمن عبد المقصود

البيساتين - القاهرة



٢٧٧١٠٢٨٠١٣٠٠٣

IZ1144908

١١٤٣٢٠٩٤-٢

الموخص المختص

محمود عبدالله

إفادة مركز نظم المعلومات

يعتقد،،،

مسلسل 2019583



الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو
وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي



رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار: 2026-7-11

جهة الاصدار: فرع القاهرة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للالتفاف الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس وقانون رقم 86 لسنة 2012 "الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعى
والبحث تبين أن

السيد (5) هويدا فرحان محمود حسن بطاقة رقم 27710280103003

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفحة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعه: 2026-7-11

الموظف المختص

محمود عبدالله

افادة مركز نظم المعلومات

يعتقد

مسلسل 2019583



الخطاب سارى لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى



Patient Name: howaida farhan Mhamoud	Patient ID: 29503102300689
Study Date: 14.7.2026	Age: Years

Bilateral Full Field Mammography with Complementary Ultrasound
Examinations Revealed

Findings:

- Scattered fibroglandular densities (ACR b).
- Left UOQ ill defined hyper dense mass lesion with speculated margins.
- Right UOQ oval shaped lesion with circumscribed margins.
- **Complementary Ultrasound**
- Showing corresponding left UOQ 2 o'clock zone ill defined speculated hypoechoic mass lesion with surrounding desmoplastic reaction measuring about 17.5x16mm in max dimensions, pathological vascularity on color duplex application, it is seen extending about 4.5 cm from the overlying skin and 4 cm from the nipple.
- No right breast solid or cystic lesions detected.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complex.
- Right non specific axillary lymphadenopathy.
- No left axillary pathologically enlarged LNs.
- No pathologically enlarged left supra or infraclavicular LNs.
-

Opinion:

- Left breast UOQ (2 o'clock) highly suspicious mass lesion as described (BIRADS 5) for histopathological correlation.
- Right UOQ benign looking lesion (BIRADS 3).

Thanks for reference

Dr. Manar Osman, MD

Patient's Name:	Howaida Farhan Mahmoud Hassan
Date:	2026-09-12
Referred by:	Prof.Dr. no doctor
Hospital:	Goustave Roussey International Egypt

**MULTISCLICE NON CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:**

Known case of breast CA.

I- CHEST:

- Left breast mass lesion measuring 31 x 26 mm for sono-mammography.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II-ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal plain CT appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Tiny left iliac bone lytic focus.

Opinion:

- ❖ No pulmonary or hepatic metastatic lesions.
- ❖ Tiny left iliac bone lytic focus is seen for bone scan.

Dr.Sherif Wagdy

Patient Name	هويدا فرحان محمود حسن	Case No.	361812
Sex/Age	Female 48 Y	Patient No.	26562
Registered Date	01/9/2026 09:05:01 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	20/9/2026 11:15:30 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	21/9/2026 09:50:12 AM	Pathology No.	SR-1004/26

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer.

Nature of Specimen: Slide revision.

Gross Examination:

- Four referred paraffin blocks marked by patient's Arabic name and four H&E-stained slides.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma
- Tumor size: Refer to original report 3x2 cm.
- Histologic grade: 2 (differentiation 2, pleomorphism 2, mitosis 2).
- DCIS: Present, intermediate grade, solid with comedo necrosis, 5%.
- Skin: Free.
- Resection margins: Refer to original report (free).
- Lymph node involvement: Free of tumor metastasis (0/6).

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: No nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- PR: No nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: No membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 20%.

Conclusion:

Left breast cancer, wide local excision and sentinel lymph nodes, Slide revision:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.
- DCIS: 5%, Intermediate grade, solid with comedo necrosis.
- Skin: Free.
- Resection margins: Refer to original report



Patient Name	هويدا فرحان محمود حسن	Case No.	361812
Sex/Age	Female 48 Y	Patient No.	26562
Registered Date	01/9/2026 09:05:01 AM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	20/9/2026 11:15:30 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	21/9/2026 09:50:12 AM	Pathology No.	SR-1004/26

- Lymph nodes: Free of tumor metastasis (0/6).

- Stage: pT2, N0

IPt:

- ER: Negative (score 0/8).

- PR: Negative (score 0/8).

- Her2: Negative (score 0).

- Ki67%: 20%.

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

** Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Prof. Dr. Maha Guinei, MD, PhD.

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim. MD.



عمرية رقم (4) - الطور الأول - مبنى رقم (987) - مركز فحص النخيل - مصر (القاهرة) - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nite Corniche - Mistr El Qadema - Cairn, Egypt